

SokrAI

Informe de propuesta

Triage IA en Urgencias

Material para revisión humana. No sustituye una revisión clínica, legal ni regulatoria.

Pendiente de validar

Generado: 18 jun 2026, 12:30

5

Secciones recogidas

2

Aspectos pendientes

1

Materiales usados

3

Avisos

Aviso de uso

Este documento prepara una propuesta para revisión. Las conclusiones deben ser revisadas por una persona responsable antes de cualquier uso real.

Resumen ejecutivo

Madurar una propuesta de apoyo al triaje antes de evaluarla en comité interno.

Problema que aborda

El triaje inicial se retrasa durante horas punta y genera variabilidad en la priorización.

Solución propuesta

La solución propuesta es un asistente local que estructura la información inicial, detecta campos...

Usuario afectado

Enfermería de admisión y coordinación de urgencias

Responsable del problema

Coordinación operativa de urgencias

Foco para la revisión

Antes de continuar, conviene resolver o validar 2 aspecto(s) pendiente(s).

Vista general de la propuesta

Evidencia disponible

Registros internos indican esperas de 20 a 35 minutos, quejas recurrentes y diferencias entre turnos.

Alcance

Piloto local en admisión adulta de urgencias, sin diagnóstico automatizado ni decisión clínica autónoma.

Alternativas actuales

Protocolo manual, notas de admisión y coordinación verbal entre profesionales.

Supuestos conocidos

- El equipo puede trabajar inicialmente con datos anonimizados o sintéticos.
- La solución se limita a ordenar información y sugerir preguntas de apoyo.
- El protocolo actual puede convertirse en campos mínimos revisables.

Ambigüedades por validar

- Aún falta confirmar la métrica basal que se usará para comparar el piloto.
- La integración con sistemas clínicos queda fuera de esta versión.

Mapa de revisión

Problema

Recogida

Hay material redactado para revisión humana.

Solución

Recogida

Hay material redactado para revisión humana.

Datos, IA y privacidad

Requiere revisión

1 aspecto(s) pendiente(s) en esta parte.

Revisión sanitaria y regulatoria	Recogida	Hay material redactado para revisión humana.
Piloto y recursos	Requiere revisión	1 aspecto(s) pendiente(s) en esta parte.

Información recogida

Objetivo

Madurar una propuesta de apoyo al triaje antes de evaluarla en comité interno.

Usuario objetivo

Enfermería de admisión y coordinación de urgencias

Responsable

Coordinación operativa de urgencias

Problema

El triaje inicial se retrasa durante horas punta y genera variabilidad en la priorización.

Evidencia

Registros internos indican esperas de 20 a 35 minutos, quejas recurrentes y diferencias entre turnos.

Alcance

Piloto local en admisión adulta de urgencias, sin diagnóstico automatizado ni decisión clínica autónoma.

Alternativas actuales

Protocolo manual, notas de admisión y coordinación verbal entre profesionales.

Secciones preparadas

Problema

Preparada

El problema principal es operativo: en horas punta, la admisión y clasificación inicial no siempre recibe información completa con la misma rapidez ni con el mismo criterio entre turnos.

La consecuencia es una espera inicial mayor, más coordinación manual y menor consistencia en la preparación del caso para revisión sanitaria.

El alcance se limita a ordenar información de entrada y apoyar al personal; no se propone diagnóstico automatizado ni sustitución de criterio clínico.

Solución

Preparada

La solución propuesta es un asistente local que estructura la información inicial, detecta campos incompletos y sugiere preguntas de seguimiento para el personal de admisión.

El asistente debe funcionar como apoyo operativo y dejar trazabilidad de la información usada. Las recomendaciones requieren siempre revisión humana.

La primera versión debería probarse con datos sintéticos o anonimizados, sin integración directa con historia clínica.

Datos, IA y privacidad

Preparada

La propuesta puede evaluarse inicialmente sin datos reales de pacientes. Para cualquier piloto con datos sensibles será necesario definir base legal, minimización, controles de acceso y registros de uso.

La IA no debe tomar decisiones clínicas. El sistema solo puede ayudar a ordenar información y a recordar preguntas de protocolo.

Cualquier salida del asistente debe ser revisable por el profesional responsable.

Revisión sanitaria y regulatoria

Preparada

Con el alcance descrito, la propuesta debe mantenerse como apoyo administrativo/operativo en v1. Si el sistema empieza a recomendar prioridad clínica, cambia el perfil de riesgo y requiere revisión regulatoria específica.

La versión piloto debe documentar límites de uso, supervisión humana y criterios de escalado.

Piloto y recursos

Preparada

El piloto recomendado es pequeño y controlado: un flujo de admisión, un periodo acotado, datos sintéticos o anonimizados y revisión diaria de resultados.

Los recursos mínimos son una persona responsable del área, personal de admisión participante, soporte técnico local y una métrica de comparación antes/después.

Aspectos pendientes

Pendiente - Piloto y recursos

Entorno piloto

Confirmar la métrica basal del piloto y el periodo de comparación antes/después.

Para avanzar: ¿Qué indicador y ventana temporal usará el equipo para medir mejora?

En preparación - Datos y privacidad

Controles de privacidad

Validar controles de privacidad antes de probar con datos reales o pseudonimizados.

Para avanzar: ¿Qué responsable revisará el tratamiento de datos antes del piloto?

Material de apoyo

Texto inicial

Usado en el informe

Texto inicial de la propuesta y respuestas de aclaración

Avisos importantes

Límite de uso

Este informe no es un dictamen clínico, legal ni regulatorio.

Límite de uso

Este informe no aprueba, rechaza, prioriza ni clasifica la propuesta.

Límite de uso

El contenido requiere revisión humana competente antes de cualquier decisión.

Privacidad

No introduces datos reales de pacientes en esta versión local de demostración.

Lista de revisión

Problema claro	Recogido	Revisar antes de compartir.
Usuario afectado definido	Recogido	Revisar antes de compartir.
Solución descrita	Recogido	Revisar antes de compartir.
Datos y privacidad considerados	Recogido	Revisar antes de compartir.
Aspectos sanitarios acotados	Recogido	Revisar antes de compartir.
Piloto y recursos tratados	Recogido	Revisar antes de compartir.
Revisión humana requerida	Recogido	Revisar antes de compartir.

Próximos pasos recomendados

1. Completar la información pendiente antes de compartir el informe como versión final.
2. Validar los puntos abiertos con la persona responsable del área.
3. Revisar privacidad, datos y límites sanitarios si la propuesta cambia de alcance.